

1 影像所见概要

片种	主要部位	发现	临床意义（通俗解释）
CT 矢状位重建 (2025-04-06)	T11-L2	- T12椎体呈轻-中度楔形压缩，前缘高度约较后缘降低 $\approx 20\text{-}25\%$ - 后壁连续、未见骨折片向椎管后突 - 椎弓、棘突及邻近椎体骨皮质完整	典型 AO-Spine A1 （单纯压缩）型；骨折局限于前柱，属 稳定性良好 骨折
MRI T2-加权矢状位 (2025-04-07)	T10-L3	- T12椎体内可见高信号 $\rightarrow$ 骨挫伤/水肿 - 椎管形态正常，未见硬膜囊受压 - 脊髓无高信号 $\rightarrow$ 未见脊髓损伤 - 后纵韧带/棘间韧带走形尚规则	证明骨折为 新鲜 且无明显神经、后方韧带损伤；再次印证 稳定性良好
椎间盘、相邻椎体	T11-L1	椎间隙高度及信号基本对称，暂未见显著盘突出	说明受伤主要集中在骨质本身

2 初步影像学分型与稳定性判断

评估框架	结论
Denis 三柱理论	前柱受累（楔形压缩）；中柱、后柱完整 → 稳定性骨折
AO-Spine胸腰椎分型	A1.2（<1/3 楔形压缩，无后壁累及）
TLICS 评分†	· 形态 1 分（压缩）· 神经 0 分（无症状）· 韧带 0-1 分（MRI 未见明确损伤） 总分 ≈1-2 分 < 4 → 建议保守治疗
†TLICS=Thoracolumbar Injury Classification and Severity Score	

3 与您现行治疗的一致性

- 平躺休息 + 胸腰支具 = 国际/国内指南对 A1 型压缩骨折的首选方案
- 3-4 周后复查（X 光或低剂量CT）是常规做法，用于确认无进行性塌陷
- 若后续塌陷 <50 % 且椎体后缘不后突，一般无需手术

4 后续检查与随访建议

时点	建议检查	目的
第 4-6 周	立位侧位 X 光（胸腰段）	评估在负重状态下椎体高度是否继续丢失
第 12 周	X 光或低剂量 CT	确认骨痂形成、楔角稳定
出现新症状时	MRI（加 T1、STIR）、脊髓评估	排除迟发神经压迫或骨不连

5 康复要点速览

时段 (自受伤算起)	允许/鼓励的动作	禁忌
0-4 周	全程背架下翻身、基础四肢等长练习、踝泵	坐起、弯腰、负重站立
4-8 周	逐步直立站立 ≤5 min/次，骨盆后倾、腹式呼吸训练	裸背架站立、搬重物
8-12 周	核心稳定训练（平板支撑改良版）、快走	跑跳、深蹲、扭腰
>12 周	渐进式负重（背包≤5 kg）、椎旁肌抗阻	高冲击运动、举重训练

所有训练须在康复师或医生指导下进行，并依据复查结果个体化调整。

6 温馨提醒

- 1. **疼痛是安全阈值：**出现持续≥2 天的明显加重，应暂停训练并就诊。
- 2. **维生素 D/钙质摄入：**每日 800-1000 IU Vit D + 1000-1200 mg 钙，总量包含食物。
- 3. **戒烟限酒、体重管理** 可降低后期椎体再次压缩风险。
- 4. 最终诊断及任何治疗方案更改，必须结合**面对面体格检查、完整序列影像**和您的【主治医师】综合判断。

免责声明

本回答基于您提供的静态截图进行的远程、非正式阅片意见，只作大众健康科普。并非正式影像报告，不构成医疗诊断或处方。请以您当地有执照的脊柱骨科/放射科专家的结论为准。祝早日康复!